

2024 [심계내과학2] [신용진] 써머리 보는 법

📌 써머리 보는 법 📌

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜** ✨: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, **밑줄**, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

17-6

신경 변성 질환

대뇌변성질환 - 치매

1. 개요

[개념]

한번 획득한 뇌 기능이 뇌 손상으로 인해 지속적인 인지 기능 장애를 일으켜 일상적 혹은 사회생활 대인관계가 명백히 장애를 입은 상태
↳ 만성으로 진행되는 뇌신경 변성 → 기억장애, 지적기능의 상실 → 임상 증상

cf) WHO - 일단 정상적으로 발달한 지적 기능이 후천적인 뇌기질성 질환에 의해 저하된 상태로
인지 기능 복수 영역의 장애에 의해 일상적인 활동에서 자립이 저하되는 장애

[치매의 정의] - WHO의 ICD-10에서

치매는 뇌질환에 의한 증후군이며, 보통은 만성 또는 진행성을 보이고, 기억, 사고, 지남력, 이해, 계산, 학습 능력, 언어, 판단을 포함한 다수의 고차원적 피질 기능의 장애를 나타낸다. **의식의 혼탁은 없다**. 인지장애는 보통 감정의 통제, 사회행동 또는 동기부여의 저하를 동반하지만, 경우에 따라서는 그것들이 선행되는 경우도 있다. 이 증후군은 알츠하이머병, 뇌혈관성 질환, 그리고 일차성 또는 이차성으로 뇌의 장애를 일으키는 다른 병태로 나타난다.

[정신 지체와의 차이점]

- 치매 - 정상으로 발달한 지능이 **후천적인** 어떤 원인에 의해서 저하되어 사회적인 적응곤란을 일으킨 상태
- 정신 지체 - **처음부터** 지능이 발달하지 않을 제자리에 있는 상태

[역학] - 빈도

- 전체 치매 中 : 알츠하이머(最多) - 뇌혈관성 치매(2번째)
- 신경변성질환 중에서만 보면 : 알츠하이머병 - Lewy 소체형 치매 - 전두측두형 치매 순
- 65세 이하 : 전두측두형 치매가 2번째로 많음

[피질치매와 피질하치매]

	피질치매	피질하치매
정의	대뇌피질의 파괴로 발병	대뇌 기저핵, 뇌간에 중심적인 병변 有
종류	알츠하이머병, Pick병, 뇌혈관성 치매의 대부분, Creutzfeldt-Jakob 등	Huntington병, 진행성 핵상 마비 등
차이점	획득한 지능 그 자체가 소실	획득한 지능을 마음대로 쓸 수 없음

[DSM 기준 치매 진단] - DSM-5의 6개의 신경 인지 영역

인지 영역	장애의 내용	구체적인 예시
복합주의력	지속성 주의, 분산 주의, 선택성 주의, 처리 속도 장애	주의력과 집중력이 저하되고, TV/라디오에 집중하기 어려우며, 사고나 이해력이 떨어짐
실행기능	계획, 의사결정, 작업기억, 피드백/오류의 정정 응답, 습관무시/억제, 심적 유연성의 장애	복잡한 계획의 입안과 수행이 불가하고 동시에 2개의 일을 하지 못하며, 일상생활에서의 기기 사용에 도움이 필요함 ex) 원래 안 그랬는데 밥을 지어먹지 못함
학습과 기억	즉시 기억, 단기기억(자유 재생, 단서재생,재인기억), 장기기억(의미기억, 자전적 기억), 잠재적 학습의 장애	- 단기 기억장애에 의한 최근 사건을 떠올리지 못하는 것이 특징적 - 진행되면 대화 중 같은 말을 반복함. - 쇼핑 항목이나 그날의 일정을 떠올리지 못함 - 알츠하이머병에서는 단기기억이 초기부터 고도의 장애를 받지만, 의미기억, 자전적 기억, 철차기억은 비교적 오랫동안 유지됨
언어	표출성(운동성)언어(환어, 호칭, 유창성, 문법과 구문)와 수용성(감각성)언어의 장애	- 대명사가 늘어나고 명칭보다 일반어를 사용함. - 중증에서는 문법상의 오류가 나타나고 반향어와 혼잣말을 거쳐 무언증이 됨. 전두측두형 인지증의 원발성 실어증에서 전형적인 증상이 나타남
지각 - 운동	시각성 인지, 시각 구성, 지각-운동, 실행행위, 인지인식 등의 장애	실행(apraxia)으로 인해 도구나 교통수단 이용에 어려움이 있으며, 실인증에 의한 익숙한 풍경이나 장소, 인물 얼굴을 인식할 수 없음
사회인지	표정으로부터 감정을 식별하는 능력과 마음이론 (다른 사람의 정신 상태나 경험을 배려하는 능력)의 장애	- 사람의 표정에서 감정을 읽어내는 능력이나 이야기 카드에서 주인공의 생각이나 의도를 추측하는 능력이 장애를 받고, '분위기를 파악하지 못하는 사람'이 됨. 진행되면 사회적 수용범위를 초과하는 극단적인 말과 행동(복장, 정치적, 종교적, 성적 화제), 타인에 대한 배려의 결여, 병식결여가 두드러짐. - 행동장애형 전두측두형 인지증에 특징적임

* DSM-4에서는 **기억장애**와 다른 인지영역의 1개 이상의 장애로 정의 → 꼭 기억장애를 포함했어야 함
DSM-5에서는 **학습과 기억을 포함한 6개의 영역 중 1개 이상의 장애**로 변경

신경인지장애(= 치매)의 진단 기준

- A. **1개 이상**의 인지 영역(위 표에 있는 6개의 영역)에서 '과거의 행동 수준에서 유의미한 인지 기능의 저하가 있다.'에 대한 증거는 다음 항목에 근거한다.
- (1) 본인, 본인을 잘 알고 있는 정보제공자 또는 임상이에 의한 유의미한 인지 기능의 저하가 있다는 우려 및
→ 누군가가 알고 있다는 사실
 - (2) 가능하면 표준화된 신경심리학적 검사에 기록된 평가, 없으면 다른 정량화된 임상적 평가에 따라 증명된 인지행동 장애
- B. 인지 결손에 의해 **독립적 일상생활이** 저해된다.
(즉, 최소한 청구서를 지불하고 복약약을 관리하는 등 복잡한 수단적 일상생활 동작에 도움을 필요로 한다.)
- C. 그 인지결손은 섬망의 상황에서만 일어나는 것은 아니다.
- D. 그 인지결손은 다른 정신질환으로 잘 설명되지 않는다. (ex - 우울증, 조현병)

* 신경인지장애의 진단이 이루어지면 다음 항목을 특정한다.

→ 원인 질환

→ 행동장애(정신병 증상, 기분장애, 초조, 무감각증, 기타)의 유무

→ 중증도

- ① 경도(가사, 금전관리와 같은 수단적 일상생활 동작의 어려움)
- ② 중등도(식사, 탈의와 같은 기본적 일상생활 동작의 어려움)
- ③ 중도(완전 의존)

경도인지장애의 진단 기준

- A. 1개 이상의 인지 영역(위 표에 있는 6개의 영역)에서 '과거의 행동 수준에서 유의미한 인지 기능의 저하가 있다.'에 대한 증거는 다음 항목에 근거한다.
- (1) 본인, 본인을 잘 알고 있는 정보제공자 또는 임상가에 의한 유의미한 인지 기능의 저하가 있다는 우려 및
→ 누군가가 알고 있다는 사실
 - (2) 가능하면 표준화된 신경심리학적 검사에 기록된 평가, 없으면 다른 정상화된 임상적 평가에 따라 증명된 인지행동 **경도** 장애
- B. 매일 활동에서 인지 결손이 **자립을 저해하지 않는다.** → 독립적 생활 可
(즉, 최소한 청구서를 지불하고 복용약을 관리하는 등 복잡한 수단적 일상생활 동작은 유지된다.
다만, 이전보다 커다란 노력, 대상적 방법, 또는 연구가 필요할 수도 있다.)
- C. 그 인지결손은 섬망의 상황에서만 일어나는 것은 아니다.
- D. 그 인지결손은 다른 정신질환으로 잘 설명되지 않는다. (ex - 우울증, 조현병)

* 경도인지장애의 진단이 이루어지면 다음 항목을 특정한다.

→ 원인 질환

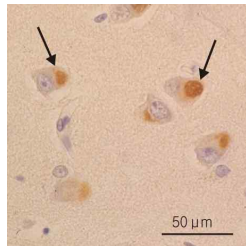
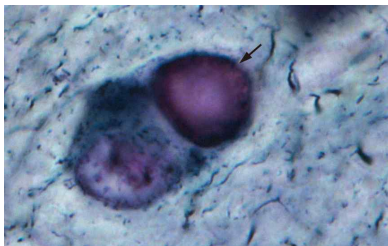
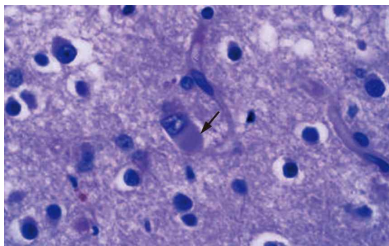
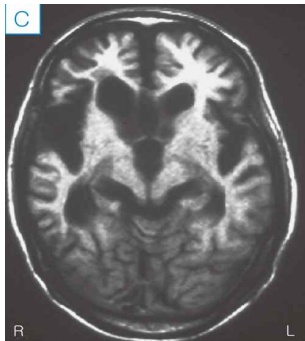
→ 행동장애(정신병 증상, 기분장애, 초조, 무감각증, 기타)의 유무

2. 치매의 원인

* 알츠하이머병, Pick병, 뇌혈관성 치매, Binswinger 뇌증, 정상압 수두증

[알츠하이머병] - 뒤에서 자세하게 설명

[Pick 병]

개요	[호발 연령] 45 - 65세 (알츠하이머에 비해 1/5 정도 드물고) [호발 성별] 남성에게 많이 발생 [특징] ❶ 진행성 ❷ 전두엽 또는 측두엽(드물게 두정엽)의 국한성 위축 → 정신 증상										
증상	❶ 기명력¹⁾ 장애보다 전두엽 또는 측두엽의 장애를 나타내는 증상이 먼저, 강하게 나타남 ❷ 초기부터 인격장애, 정서장애가 중심적 ❸ 병을 자각하지 못함, 이상행동, 반향언어 ❹ 진행 시 기억장애 뚜렷, 기호 행동의 저하 → 추체로 장애, 운동감각 마비 ❺ 5-7년 경과 후 합병증으로 사망 / 예후 불량										
		<table><thead><tr><th></th><th>전두엽형</th><th>측두엽형</th></tr></thead><tbody><tr><td>초기 증상</td><td>인격 변화로 시작 → 무관심한 생활태도, 자발성 감퇴</td><td>실어증으로 시작 → 감각실어, 의미성 착어²⁾</td></tr><tr><td>경과</td><td> - 협조성 상실, 욕동적 탈억제 → 기이한 행동, 거친행동 ↳ 욕망과 충동 - 사유의 빈곤: 상대 무시, 바보같은 태도, 엉뚱한 대답 진료 중 자기 맘대로 나가는 능 - 같은 말의 반복, 반향언어 - 자발성의 감퇴, 무언 상태 [말기] 원시반사, 추체로 징후, 추체외로 징후 등 와병상태가 되어 사망 </td><td>진행하면 인격 변화가 두드러지며, 전두엽형과 동일한 경과</td></tr></tbody></table>		전두엽형	측두엽형	초기 증상	인격 변화로 시작 → 무관심한 생활태도, 자발성 감퇴	실어증으로 시작 → 감각실어, 의미성 착어 ²⁾	경과	- 협조성 상실, 욕동적 탈억제 → 기이한 행동, 거친행동 ↳ 욕망과 충동 - 사유의 빈곤: 상대 무시, 바보같은 태도, 엉뚱한 대답 진료 중 자기 맘대로 나가는 능 - 같은 말의 반복, 반향언어 - 자발성의 감퇴, 무언 상태 [말기] 원시반사, 추체로 징후, 추체외로 징후 등 와병상태가 되어 사망	진행하면 인격 변화가 두드러지며, 전두엽형과 동일한 경과
		전두엽형	측두엽형								
초기 증상	인격 변화로 시작 → 무관심한 생활태도, 자발성 감퇴	실어증으로 시작 → 감각실어, 의미성 착어 ²⁾									
경과	- 협조성 상실, 욕동적 탈억제 → 기이한 행동, 거친행동 ↳ 욕망과 충동 - 사유의 빈곤: 상대 무시, 바보같은 태도, 엉뚱한 대답 진료 중 자기 맘대로 나가는 능 - 같은 말의 반복, 반향언어 - 자발성의 감퇴, 무언 상태 [말기] 원시반사, 추체로 징후, 추체외로 징후 등 와병상태가 되어 사망	진행하면 인격 변화가 두드러지며, 전두엽형과 동일한 경과									
병리	- 전두엽 또는 측두엽의 국한성 위축 (알츠하이머병에서 나타나는) 노인반, 신경원섬유 변화는 나타나지 않음 - 위축 부위 뚜렷한 Pick 세포, 세포질 내 기은성 구형 봉입체 관찰 										
진단	- 영상진단: 전두엽, 측두엽의 위축 A  C  - 기명력 장애보다 인격장애가 먼저 나타나는 경우 Pick병을 고려 ex) 평소 양전한 사람이 난폭하고 기명력이 감소하면 Pick병을 고려해볼 수 있음										

1) 기명력 - 새로운 경험을 받아들이는 능력

2) 의미성 착어 예시 - 딸기를 말하고 싶은데 사과로 말함

[뇌혈관성 치매]

- 정의 - 뇌혈관성 장애에 의한 대뇌반구의 병변에 근거하는 치매의 총칭 (다발성 열공 경색, 뇌경색 등으로 치매 발병)
- 특징 - 계단상의 증상 악화, 증상의 동요성 有 / (알츠하이머형 치매에 비해) 인격이 유지되는 경우 多

[Binswinger 뇌증]

- 정의 - 뇌혈관 치매의 일종 / 대뇌피질의 경색으로 야기된 치매
- 특징 - 난치성 고혈압, 전신의 동맥경화 동반

[정상압 수두증]

- 정의 - 수두증으로 인한 치매
 - ↳ ㄱ 뇌척수압은 정상이지만 뇌척수액의 흡수 장애로 나타남 (뇌척수액로 폐쇄 없이 유지됨)
 - ↳ 3대 증상: 보행장애, 요실금, 치매

cf) 교과서 내 치매를 일으키는 질환 (표 17-3-5)

I. 뇌질환 1. 중추신경 변성질환 피질성 알츠하이머병(alzheimer's disease) 전두측두엽 변성증(타우단백질이상증, 유비퀴틴이상증, 기타) 피질하성(대뇌기저핵 질환) Lewy소체형 인지증(피질성 증상만 있는 경우도 있다) 파킨슨병 인지증, 파킨슨병 진행성핵상마비 대뇌피질기저핵변성 헌팅턴병(huntington's disease) 괌(Guam)과 기이(紀伊)반도의 파킨슨병 인지증 복합 척수소뇌변성증 2. 뇌혈관장애 허혈성 출혈성 소혈관병, 유전성 가족성 뇌혈관장애 3. 뇌신경외과질환 뇌종양 두부외상 만성경막하혈종 수두증 4. 중추신경탈수질환 다발성 경화증, 시신경척수염, 급성 파종성 뇌척수염 (acute demyelinating encephalomyelitis) 5. 중추신경감염증 급성 바이러스성 뇌염: 단순 헤르페스 뇌염, 일본뇌염 지발성 바이러스감염증: 진행성 다발성 백질뇌병증, 아급성 경화성 범뇌염 HIV뇌증, 뇌의 기회감염 뇌수막염, 뇌농양: 일반세균, 결핵균, 진균, 원충, 매독 6. 프리온병 크로이츠펔트 야콥병(Creutzfeldt-Jakob disease), 게르스트만-슈트 로이슬러-샤인커병(gerstmann-straussler-scheinker syndrome), 쿠 루병(kuru disease)	II. 전신질환에 의한 뇌장애 1. 대사성 질환 간성뇌증, 저혈당, 요독증, 전해질 이상, 저산소증, 윌슨병(wilson's disease), 미토콘드리아이상증 2. 내분비질환 뇌하수체 기능저하증, 갑상선 기능저하증, 부갑상선 질환, 쿠싱증후 군(cushing's syndrome), 에디슨병(Addison's disease) 3. 영양결핍증, 알코올 관련 질환 베르니케 코사코프 증후군(비타민 B1결핍증), 페라그라(니코틴산결 핍증), 아급성 척수연합변성증(비타민 B12결핍증), 마르키아파바-비 나미병(Marchiafava-Bignami disease) 4. 전신감염증 HIV, 일반세균 5. 자가면역질환 · 염증성 질환 · 신생물발립증후군 콜라겐병, 혈관염, 사르코이드증(sarcoidosis) 베체트증후군, 변연계 뇌염 6. 중독 중금속 일산화탄소 유기화합물(톨루엔 등) 7. 약물 정신신경작용제 그 밖의 약물 III. 정신질환에 의한 가성 인지증 우울증, 양극성 장애(bipolar disorder), 조현병, 신경증, 해리성 장애
--	--

3. 치매의 유형

[1] 알츠하이머병

1. 정의/개념

- 진행성 치매의 양상을 보이며 **신경세포 탈락**과 함께 **노인성 반점**이나 **신경원섬유 변화**를 보이는 병태
- 변성 질환 치매 중 **최다** / **두정엽 및 그 연합영역**에 병변이 존재
- 서서히 지능, 기억, 추론 능력, 새로운 것에 대한 학습 능력 저하 → 타인과 의사소통 힘들어짐
- 성격 변화를 동반한 행동 심리 장애, 판단력 상실 → 단순한 일상생활 능력 유지 곤란, 단독 생활 불가
- 증상 발현 후 20년까지 다양한 기간 지속되나, 통상 발병 후 약 **8-10년 내 사망**

☑ DSM-5 분류상 알츠하이머병의 정의

- 다양한 인지 장애의 발현
 - 기억장애 (새로운 정보를 학습하거나 이전에 학습한 정보를 기억해내는 능력의 장애)
 - 다음 인지 장애 중 하나 (또는 그 이상)
 - 실어 / 실행 / 실인 / 실행기능(계획 세우기, 조직화하기, 순서 정하기, 추상화하기)의 장애
- 상기 인지장애는 각각이 사회적 또는 직업적 기능의 현저한 장애를 불러일으키고 발병 전 기능 수준에서 현저한 저하를 보인다.
- 경과는 완만한 발병과 지속적인 인지 저하로 특징지을 수 있다.
- a의 인지 장애는 다음과 같은 원인에 의한 것이 아니다.
 - 기억이나 인지에 진행성 장애를 일으키는 다른 증후신경계 질환
(예 - 뇌혈관장애, 파킨슨병, 헌팅턴병, 경막하혈종, 정상압수두증, 뇌종양)
 - 치매를 일으키는 전신성 질환
(예 - 갑상선 기능 저하증, 비타민B12 or 엽산 결핍증, 니코틴산결핍증, 고칼슘혈증, 신경매독, HIV감염증)
 - 물질 유발성 질환 - **유독물질**
- 그 장애는 섬망 경과 중에만 나타나는 것이 아니다. → **지속적이어야 함**
- 그 장애는 다른 제1축의 질환으로는 설명되지 않는다. (예 - 우울증, 조현병)

2. 분류

- └ 만발성 - 노년기 발병 타입
- └ 초발성 - 초로기 발병 타입

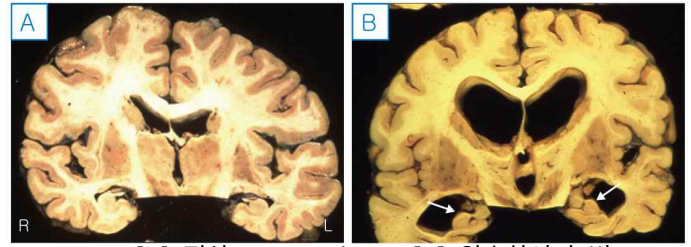
↳ 만발성에 비해 경과가 급속하고, 비교적 초기부터 일어나 실행이 나타나기 쉽고, 가족성의 빈도 高

3. 병리/병인/병태생리

(1) 병리

① 신경 세포와 시냅스의 탈락

- * 대뇌피질의 신경 세포 탈락, 과립 공포 변성 → 대뇌 위축
 - (대뇌 위축에 따른) 뇌실 확대
 - 대부분 해마를 중심으로 한 측두엽 내측면부터 위축
 - 두정엽, 후두엽도 점차 위축
 - (그 이후에) 대뇌피질 전역, 백질, 기저핵 위축

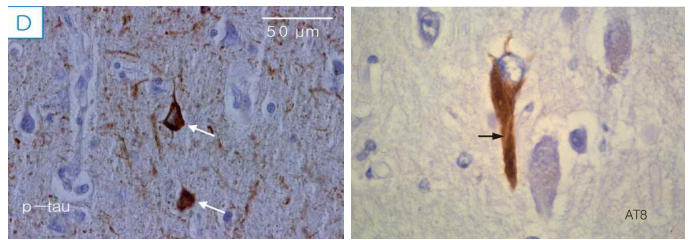


[A] 정상 / [B] 알츠하이머 병

→ 화살표 부분 = 해마 ([B] 사진에서만 비어있음)

② 신경원섬유 변화 (neurofibrillary tangle, NFT)

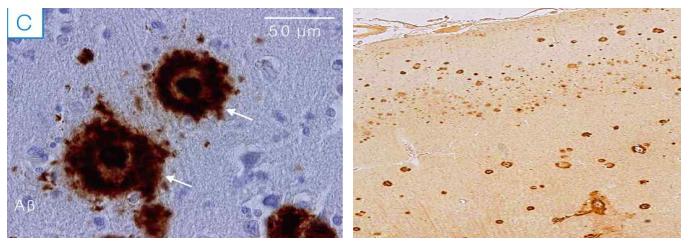
- 타우 단백질의 과잉 인산화로 인해 사행형을 나타냄
 - ↳ 신경 세포 내 존재하는 신경원 섬유
 - * 사행형: 뱀이 기어가는 형태



→ 화살표 부분 = 인산화 타우 단백질의 과잉 축적

③ 노인반 (senile plaque)

- A β 단백의 뇌 내 축적으로 노인반 형성
 - ↳ APOE(APO 단백질): 발병 촉진 위험인자로 추측됨

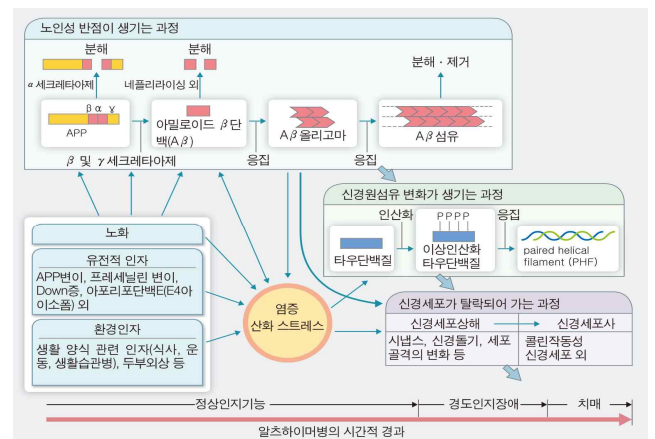


[확대해서 본 것]

[대뇌피질을 잘라서 본 것]

(2) 병인, 발병기전

- A β 의 응집, 축적으로 인해 발병
- 고위험 요인: 두부외상, 당뇨, 고혈압, 이상지질혈증 등
- 노화로 인해 유전적 인자나 후천적 인자가 다인자성으로 작용하여 발병
- 원인 유전자 (총 4개 ①②③④)
 - 단일유전: ① 21번 염색체의 β APP 유전자 돌연변이
 - PS1
 - PS2
 - 다인자유전: ④ 19번 염색체의 APOE



노화, 유전적 인자, 환경인자 → 노인성 반점이 생기는 과정 →
신경원섬유 변화가 생기는 과정 → 신경 세포가 탈락되어가는 과정 →
시간이 경과함에 따라 치매

4. 역학

- 노화와 함께 유병률 증가
- 남성보다 여성이 높음 (남:여 = 1:3)
- 대개 산발성, 일부 유전성

cf) Pick병은 여성보다 남성이 높음

5. 임상증상 및 경과

(1) 증상의 개요

- ① 일반적으로 증상이 나타난 후 10-15년 혹은 2-20년 사이(길게 20년) 다양한 기간에 지속
- ② 치매와 동반한 인지기능 장애가 매우 서서히 진행되는 특징
- ③ 대뇌의 전반적인 위축을 반영 → 모든 지능이 손상되는 전반성 치매로 이행
- ④ 경과 중 섬망, 환각, 망상, 억울, 불안, 초조감, 배회, 폭행 등의 다양한 증상 출현
- ⑤ 개인차, 환경적 요인 등에 의해 종종 그 정도가 동요(변화되는 것)
- ⑥ 젊은 연령 - 실어증, 실인증 / 고령 - 기억장애 중심

(2) 정신 증상과 신경 증상

정신 증상	• 기명/기억장애로 시작 • 지적 기능 장애와 행동이상 - 계산력, 판단력, 인식력의 저하, 외출/배회 등 • Pick병에 비해 인격은 비교적 오래 유지 • 노년형 치매보다 빠른 경과
신경 증상	• 중기부터 언어상실증, 인식 불능, 행위상실 등이 현저 • 언어상실증 - 반향어, 언어간대, 초피질성 감각언어 상실증 (베르니케 실어증처럼 말은 유창, 이해/읽기에 문제) ↳ 남의 말 반복에는 문제 X • 근육경직, 종종걸음 등의 Parkinson 증상, 간질, 사지떨림 동반

(3) 경과 (초-중-말이 뚜렷하게 구분되지는 않음)

MCI 단계	최근 기억장애만 있는 단계 = 경도인지장애 (건망증이 있지만 일상생활에는 문제 X)
제1기(초기) = 경도 치매	a. 개요 가. 대부분 '건망증이 심하다'라는 호소, 증상은 모호한 경우가 많음 (주변 사람은 모를 수 O) 나. 전향성 기억상실증, 건망증, 의욕감퇴, 자발성 저하, 흥미나 관심 결여, 우울상태, 후각장애 등 ↳ 어떤 사건 이전은 기억 O / 이후는 기억 X b. 증상 가. 같은 질문을 반복한다. 나. 대화 도중 주제를 잊거나 적절한 단어를 찾아내는 데 어려움이 있다. 다. 음식 조리 등 익숙한 일이 이전에 비해 서툴러졌다. 라. 추상적 사고에 어려움이 있다. 마. 최근에 일어난 일을 기억하지 못한다. - MCI 단계보다 심해지면 몇 분 전 이야기도 기억 X 바. 물건을 엉뚱한 곳에 놓아둔다. 사. 걸으로 드러날 정도로 정신집중을 하지 못하거나 주도적으로 일을 처리하는 능력이 저하된다. 아. 주위 환경이나 돌아가는 일에 관심이 적어진다. 자. 자신의 외모나 남에게 갖추어야 할 예의범절에 무관심해진다. 차. 시간과 장소에 관한 지남력이 떨어진다. 카. 익숙한 장소에서 방향감각이 떨어져 운전이나 집 찾기가 힘들어진다. → 본인도 모르게 미아되기도 O +) 섬세함 부족, 이기적으로 변함 등의 증상이 나타나기도 함

제2기(중기)
= 중등도 치매

a. 개요

- 가. 증상이 분명해짐 → 주변 사람도 알게 됨
- 나. 전향성 기억상실증, 지남력 장애가 더욱 악화되어 독립된 생활이 위험해짐
- 다. 진행된 기억장애, 일몰 증후군, 실어, 실행, 실인, 인물오인, 환각, 망상, 거울현상, 현저한 인격 변화, 경련발작, 자세 이상, 근긴장 이상 등

* 진행된 기억장애 - 과거 이야기도 기억 X / 일몰 증후군 - 해가 지면 쏘다니는 것

* 거울현상 - 남의 표정, 행동을 그대로 따라 함

b. 증상

- 가. 전기다리미나 가스 기구 스위치 끄는 것을 잊는 등 생활 도구 사용이 힘들어진다.
ex) 냄비에 물을 붓고 불에 올리지 못함 / 옷입기 불가 등
- 나. 약 복용 같은 주기적으로 해야 할 일을 지속적으로 잊는다.
- 다. 계산력이 필요한 일이나, 계획성이 요구되는 일처리가 힘들어진다.
- 라. 읽기, 쓰기를 포함한 다른 사람과의 의사소통 능력이 저하된다.
- 마. 갑자기 화를 내거나 성격이 공격적으로 변화하거나 반대로 의기소침해진다.
- 바. 공공장소에서 부적절한 행동을 한다.
- 사. 안절부절 못하며 초조해지는 것이 점점 심해지며 특히 야간에 심하다. → 일몰 증후군 더욱甚
- 아. 잠자는 시간이 지나치게 많거나, 반대로 전혀 잠을 자지 못한다.
- 자. 환각과 망상을 하게 된다.
+) 식사, 옷입기, 배변 활동 등에 도움 必

제3기(말기)
= 중증 치매

a. 개요

- 가. 일상생활의 모든 부분에 대해 간호가 필요
- 나. 생각하거나 추론할 능력의 소실, 성격 황폐화 → 식사, 몸단장도 도움 없이 불가능
- 다. 다양한 정신기능의 고도 장애, 실외투증후군, 와상 상태, 어미반복, 반향언어 등
↳ 식물인간 st

b. 증상

- 가. 전혀 기억을 못한다.
- 나. 말을 하기도 남의 말을 이해하기도 어렵다.
- 다. 감정 표현이 거의 없다.
- 라. 물건을 잡거나 사람을 잡고서 놓아주지 않는다.
- 마. 다른 사람을 알아보지 못하며 거울에 비친 자신의 모습도 알아볼 수 없게 된다.
→ 그래서 거울에 대고 말을 걸음 (자기 자신한테)
- 바. 모든 개인 일상생활에 타인의 도움이 필요하다.
- 사. 변실금, 요실금이 생긴다.
- 아. 쇠약감이 심해지며 감염에 취약해진다.
- 자. 음식을 씹거나 삼키기 어려워 체중이 감소한다.
- 차. 농변, 이식을 보인다.
↳ 뭉든지 입에 넣음

그 후

- 침상에 고정된 상태로 몸이 쇠약해져 요로감염, 폐렴, 욕창 등의 후유증이 사망원인이 되며, 평균 8-10년 정도 생존 후 사망한다.

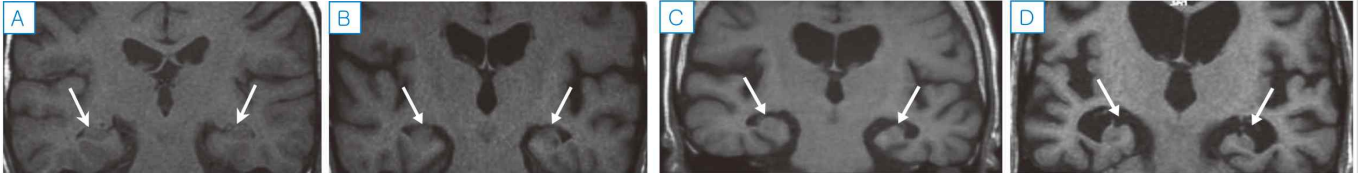
6. 검사 소견 → 증상양상 + 진단검사 + 심리검사 등이 필요

(1) 뇌척수액 검사: 타우 단백질 증가 + $A\beta$ 의 감소 조합

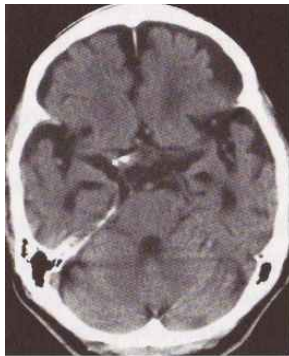
(2) CT / MRI

- ① 대뇌의 전반적 위축 / sylvius 고랑이나 뇌실의 확대
- ② 현저한 측두엽, 해마의 위축
- ③ 초기 - 약한 위축으로 확진 곤란 (영상으로 확진 어렵)

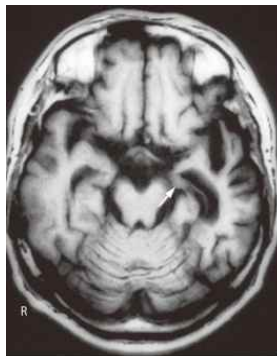
[영상 소견 예시]



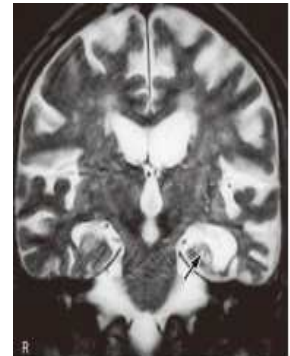
* 화살표: 해마 (A → D: 해마가 비어가는 중)



[CT] 전두엽/측두엽 위축, 고랑 확대



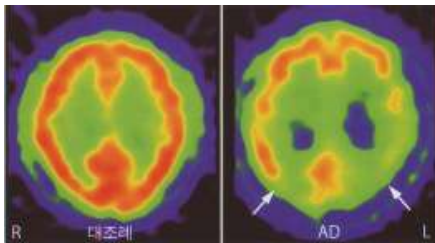
[MRI T1 강조] 좌측 측두엽이 우측에 비해 위축되어 있고 뇌실도 大



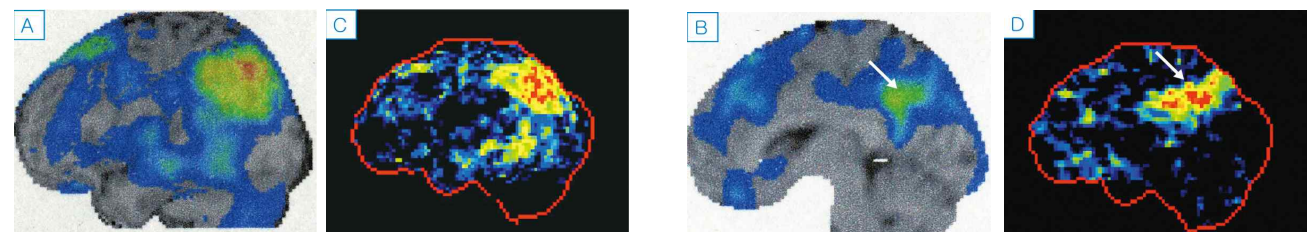
[MRI T2 강조] 좌측 해마가 위축됨 (오른쪽은 팽참)

(3) SPECT, PET: 뇌의 기능 저하 부분, 뇌혈류 ↓

[영상 소견 예시]



→ 우측 사진상 좌측 두정엽 쪽 뇌혈류 ↓ (빨간색이 덜함!!)



→ 다른 부분에 비해 빨간색으로 보이는 부분이 뇌혈류 저하 부분임

(4) 치매 평가 척도: MMSE-K(한국), HDS-R(일본) 등

7. 감별진단

- 섬망, 우울 등
- 혈관성 치매, Lewy 소체형 치매, 전두측두형 치매
- 갑상선 호르몬 저하증, 비타민 B₁, B₂결핍증, 신경매독 등
- 만성 경막하혈종, 정상압 수두증 등 → 이것에 의한 건 치료 可

8. 경과/예후

- 발병 후 약 10년 내 와상 상태
- 전신쇠약이나 요로감염, 폐렴, 욕창 등의 합병증으로 사망 → 진단 후 평균 생존 기간 = 10년

9. 정신 증상을 악화시키는 약물

- 항콜린작용, 항불안제, 수면제: 기명력 저하, 섬망 등
↳ 벤조디아제핀계 약물
- 호르몬 억제: 우울, 조증 상태, 불면 등
- 항악성종양제: 백질 뇌증
- 소화제: 섬망, 착란 등

10. 치료 → “대증요법” (신경 세포가 탈락하는 확실한 원인도, 회복하는 방법도 몰라서 근본적 치료 X)

→ 신경세포 탈락 지연/억제 등도 불가능함

약물요법	① AchE 억제제 [원리(근거)] 알츠하이머병 환자의 뇌 내의 아세틸콜린 함유량이 저하되어 있다는 사실에 근거 [효과] 초기 혹은 중기의 증상 완화 [종류] donepezil, galantamine, rivastigmine
	② NMDA glutamate receptor antagonist (N-methyl-D-aspartate 수용체 길항제) [원리(근거)] 알츠하이머병 환자의 인지기능 개선 효과 및 신경세포 보호효과가 있는 것으로 추측 ↳ 질환 자체를 막을 수는 X [효과] 중등도부터 고도 증례에 효과 [종류] memantine
비약물요법	③ BSPD(치매의 행동심리학적 증상)에 대한 대증요법 A. 행동 증상 배회, 공격적 언행, 불온, 괴성, 간병에 대한 저항, 반복적인 질문, 불어다님, 성적일탈행위, 반사회적 행위, 이식증, 일몰 증후군 (sundown syndrome) B. 정신/심리학적 증상 정신병 증상, 환각, 망상, 오인, 공격성, 충동적, 불안, 초조, 불면, 무기력, 무관심, 우울 * BSPD: 간호, 간병, 가족에게 큰 어려움을 줌 ➡ 환자와 보호자/간병인 관계 개선 시 BSPD도 약물 없이 괜찮아지는 경우도 종종 有

[알츠하이머 VS Pick 병]

임상 증상	알츠하이머병	Pick병
기억장애	조기	만기
시공간 지남력 장애	조기	만기
계산능력 상실	조기	조기에는 비교적 유지
인격 변화	만기	조기
Kluver-Bucy 증후군	만기	조기
언어장애	같은 말 반복, 언어간대	상동언어, 말기의 침묵 상태, 반복언어
경련발작	높은 빈도	극히 낮은 빈도
영상 소견	대뇌피질의 광범위한 위축	전두엽, 측두엽의 국한성 위축
병리 소견	대뇌반구 후방부 위축	대뇌반구 전반부 위축
편도체 장애	중심 및 안쪽 핵군의 장애	모든 핵의 장애
조직병리학적 소견	신경원 섬유변화, 노인반 과립 공포변성, 수상돌기의 위축	Pick 소체, 팽화신경세포 백색질신경아교증, 수상돌기 소실
화학병리학적 소견	콜린 작동성 신경 세포의 장애	비특이성 신경전달 물질의 장애

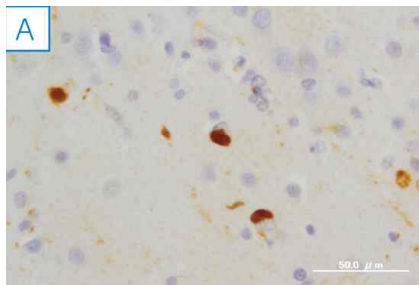
[2] Lewy소체형 치매 (DLB, Dementia with Lewy bodies)

1. 정의/개념

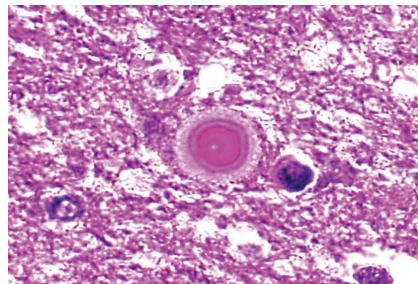
- 대뇌에서 **Lewy소체**를 특징으로 하는 치매
- 퇴행 변화에 의한 치매의 원인 질환 중 약 20%, AD(알츠하이머병) 다음으로 흔한 질환
- 임상 양상, 병의 진행과정이 AD나 다른 치매 질환과 **다른 특징적인 소견**
- 신경 이완제에 대한 **과민 반응**: 신경 이완제의 치료 중 합병증으로 가능 (다른 치매에서는 과민반응이 나타나지 X)
- 아세틸콜린 분해효소 억제제에 효과 cf) 알츠하이머도 AchE 억제제로 치료

2. 병인/병리/병태

[병태] DLB 환자의 뇌에 **Lewy소체** 및 **Lewy 신경돌기**가 광범위하게 분포 (종종 A β 침착을 수반)



[A] 여기서 반점 = 루이소체



신경세포에서 루이소체를 나타낸 것

[병리] PD(파킨슨병)와 유사

- └ PD에서도 Lewy소체가 나타나지만
- └ DLB에서는 Lewy소체가 흑질 부위뿐만 아니라 **뇌간에서 대뇌피질에 걸쳐 광범위하게 분포**
- ➔ 연수에서 상행, 편도핵에서 대뇌피질 or 뇌간으로 진행, 대뇌피질에서 뇌간 방향으로 하강하는 3가지 유형으로 추측

3. 역학 (전체 치매의 약 15-20%)

[호발 연령] 60-90세 발병, AD와 유사하나 좀 더 늦은 나이에 발병하는 것으로 알려짐

[호발 성별] 남자에서 더 호발

4. 임상 증상

주된 증상	☑ 주된 특징 = 진행하는 인지장애로 일상생활이나 작업 활동 수행에 장애가 초래되는 것
	✓ 다음 중심 증상 중 2가지가 있으면 DLB 가능성이 높으며(probable DLB) 1가지만 있으면 DLB를 의심할 수 있음(possible DLB)
	① 진행성/변동되는 인지 기능 장애 (= 동요성 인지 기능 장애) / 주의력과 각성도의 변화가 동반됨 → 몇 분 ~ 며칠 단위로 변화 (주의력 장애, 시공간 장애, 구성 장애 등)
	② 재발성 환각 (반복적인 환시, 전형적으로 정형화되고 상세함) • 주로 동물이나 사람에 관한 내용 • 환시 형상을 구체적으로 표현, 생생한 환시의 반복 → 전형적인 초기 DLB환자
	③ 자발성 파킨슨증 • 파킨슨병에 비해 상대적으로 떨림이 적고 대칭적 (파킨슨병은 먼저 떨림이 나타난 쪽이 항상 나빠지만 DLB는 대칭적 소견을 보임) • 자세 불안정이나 무표정이 더 심한 경향 • 파킨슨증이 없는 경우도 약 25% → 파킨슨"병"과 관련이 없으려면 치매 증상이 1년 전에 나타나야 함 (파킨슨병 ≠ 파킨슨증)
	④ 기타: 우울증, 망상, 무기력, BSPD, RBD(렘수면 수면장애), 자율신경계 등 ↳ 기립성저혈압, 요실금

보조 진단 증상	① 반복되는 넘어짐 ② 졸도 ③ 일시적인 의식 소실 ④ 신경 이완제에 대한 민감성 ⑤ 조직화된 망상 ⑥ 환시 이외의 환각
DLB 가능성이 낮은 경우	① 국소 신경학적 결손이나 뇌영상으로 뇌졸중이 확인된 경우 ② 신체 검진이나 검사로 임상 증상을 설명할 수 있는 다른 질환이나 다른 뇌질환이 있는 경우 → 이 증상이 나타난다면, DLB가 아님을 배제진단 할 수 있음

6. 검사

(1) Brain CT, MRI

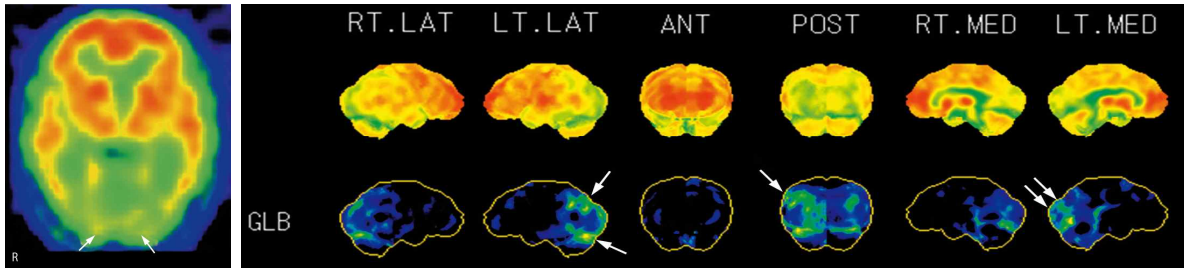
- **안쪽 측두엽** 위축

→ AD(알츠하이머병)만큼 전형적이거나 흔한 소견은 X

cf) 알츠하이머에서는 측두엽에서부터 명확

(2) SPECT, PET

- **후두엽**에서 혈류 감소나 대사 감소



[왼] 화살표 부분에서 혈류 저하 양상을 보임

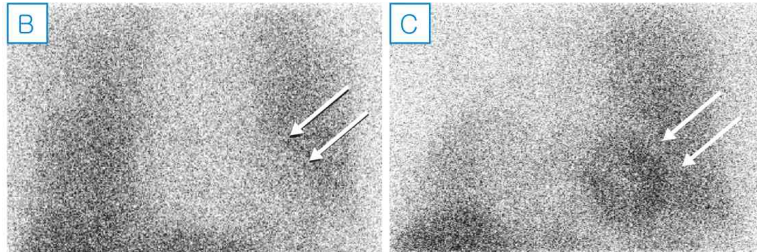
[오] 화살표 부분에서 후두엽합피질, 후두엽 혈류 저하 양상

(3) DAT 섬광조영술

- 선조체에서 도파민 집적 저하 소견을 보임

(4) MIBG 심근 섬광조영술

- MIBG의 뚜렷한 집적 저하 소견을 보임 (파킨슨병에서도 나타나긴 함)



[왼] 루이소체 치매 - 흡수가 사라짐 (검은색이 뚜렷하지 않음)

[오] 알츠하이머 or 정상 - 동그랗게 흡수 (검은색이 뚜렷)

7. 진단/감별 진단

(1) 임상진단 + 검사소견으로 진단

- ① 진행성의 인지장애와 함께 인지 기능의 변동, 환시, 파킨슨증 중 2개 이상 → 거의 확실한 DLB로 진단
- ② RBD, BSPD, 우울, 망상, 자율신경 증상 등의 보조증상

(2) AD(알츠하이머), 혈관성 치매, 진행성 핵상마비, 대뇌피질기저핵변성증, CJD 등과 감별

8. 경과/예후

- AD(알츠하이머병)에 비해 빠른 진행, 평균 10년 미만 생존

9. 치료

약물요법	① AchE(아세틸콜린 분해 효소) 억제제 • 인지 기능의 개선: DLB > AD (AD, DLB에 모두 쓰지만, DLB에 더 효과적) • 환시, 망상, 무감동이나 졸림 등에도 효과 ② 신경이완제 • 파킨슨증의 악화, 의식 저하와 자율신경계 기능 마비로 사망 가능성 • 약 40~50%에서 과민 반응 ③ 항파킨슨약제 • 파킨슨 증상의 회복을 위해 투여하지만 현저한 효과는 보이지 X
비약물요법	간호, 재활치료 등

[3] 전두측두엽 치매 (FTD), 전두측두엽 변성증 (FTLD)

* (FTD, frontotemporal dementia) $\subset$ (FTLD, frontotemporal lobar degeneration) $\rightarrow$ 임상에서는 거의 같은 말
(교과서에서는 분류했음)

1. FTLD의 정의/개념

[정의] 전두엽과 측두엽 중 먼저 손상입는 부위에 따라, 좌우 반구 중 더 손상된 부위에 따라 다양한 증상을 나타내는 치매 질환군

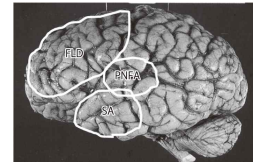
[증상] 전두엽, 측두엽에 퇴행성 병변 $\rightarrow$ 성격 변화나 이상행동, 혹은 언어장애로 시작
상대적으로 기억력이나 방향감각은 유지

[분류] 임상 증상에서 따라 ⁽¹⁾전두측두형 치매(FTD), ⁽²⁾진행성 비유창성 실어(언어상실증), ⁽³⁾의미성 실어로 분류

2. 분류 및 증상

(1) 전두측두형 치매(FTD)

- ① 정의: 인격변화나 행동 이상을 특징으로 하는 증후군
- ② 분류



$\rightarrow$ 분류별 뇌 위축 부위

① 전두엽 변성형 (FLD, frontal lobe degeneration)

70%

[특징] 40~60세에 발병, 전두엽형 Pick병과 거의 동일한 증

흑색질 변성 $\rightarrow$ 파킨슨 증후군 동반

☒ 알츠하이머병과의 차이점: 전두엽, 측두엽의 전방 부분 위축을 보이나, Pick 세포 / 신경원섬유변화 / 노인반 X

[증상] 행동장애 위주

- 탈억제형(disinhibited): 욕동 억제 불능 $\rightarrow$ 과식, 성욕 과다, 과다구강증 등의 비사회적인 행동
 $\rightarrow$ 먹을 거, 음료, 담배 등에 집착
- 무감동형(apathetic): 욕구, 의욕 저하 $\rightarrow$ 무관심, 무감동, 우울증 등
- 상동형(stereotypic): 융통성이 없어지고 반복적인 행동, 강박 증상 $\rightarrow$ 매일 같은 시간에 같은 행동

② Pick형

20%

전두엽형

- 주로 초로기(40-60)에 인격 변화로 시작 $\rightarrow$ 무관심한 생활 태도, 자발성 감퇴
- 협조성 상실, 욕동적 탈억제 $\rightarrow$ 기이한 행동, 거친 행동
- 사유의 빈곤: 상대 무시, 바보같은 태도, 엉뚱한 대답
ex) 진료실에서 마음대로 돌아다니기
- 같은 말의 반복, 반향언어
- 자발성의 감퇴, 무언 상태
- 말기 : 원시반사, 추체로 징후, 추체외로 징후 등, 와병 상태가 되어 사망

측두엽형

- ☒ 측두엽형은 Pick병에 포함되지는 않지만 교과서에서 넣어놓기만 한 것임
- 초로기에 실어증으로 시작, 감각 실어, 의미성 착어
- 진행하면 인격 변화가 두드러지며 전두엽형과 동일한 경과

③ 운동신경원형 (MND, motorneuron disease)

그 외 나머지

- 근위축성 측삭경화증: 연수 뇌신경핵 및 전각 세포의 변성 $\rightarrow$ 심부반사 항진, 병적반사, 근육위축 등
- 치매를 동반하는 근위축성 측삭경화증(ALS)이라고 볼 수 있음
- 전두엽형 Pick병과 거의 동일한 증상으로 발병
- 진행하면 ALS와 동일한 운동신경원 증상이 출현

③ 영상 소견

- 전두측두엽 위축
- SPECT, PET: 전두측두엽 뇌혈류/당대사 저하

④ 치료

- 간호 및 간병
- 대증치료: 진정제, 세로토닌 재흡수 억제제

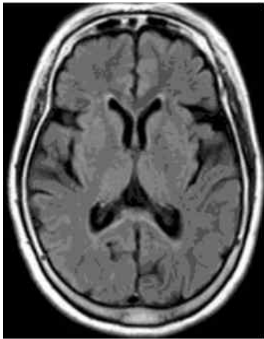
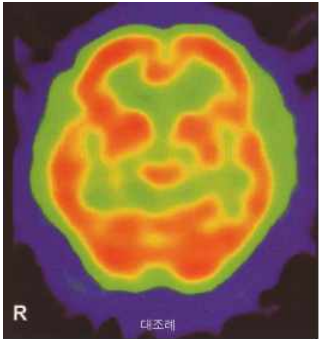
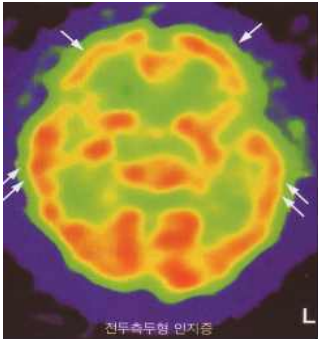
(2) 진행성 비유창성 실어(언어상실증) (PNFA, progressive non-fluent aphasia)

개요	• 서서히 발병, 점차 진행되는 언어장애 • 언어장애: 비유창성 언어장애 • 발병 초기 FTD에 비해 사회적 기능이 보존 • 행동 및 성격 변화, 원시반사 등의 신경학적 이상이 비교적 늦게 발생 ☑ 의미성 실어와의 차이점: 발병 초기 단어에 대한 언어 의미체계 보존 ☑ 알츠하이머병과의 차이점: 신경 심리검사상 심한 기억장애나 시공간 능력 장애가 없음
증상	《말을 잘 못한다》가 큰 특징 (= 비유창성) • 이야기 속도 저하, 어구의 길이가 짧아지는 전보문체 ↳ 조사(을/를)를 빼고, 단어를 온전히 말 X • 소리의 높낮이, 강약의 변화 등 억양의 자연스러움 소실 • 말을 하려고 할 때 얼굴을 찡그리거나 자세를 바꾸거나 몸을 떠는 등의 모습을 보임 ┐ 주 증상: 이름 대기 장애, 문법적 오류, 음성 착어 └ 보조적 증상: 구음장애, 입행위상실증, 따라 말하기 장애, 쓰기언어 상실증, 읽기언어 상실증 등
영상 소견	• 우성 반구의 전두엽과 측두엽을 포함한 sylvius 주위의 위축 현저 • SPECT/PET 소견: 같은 부위의 혈류 감소, 대사저하

(3) 의미성(어의성) 실어 (SA, semantic aphasia)

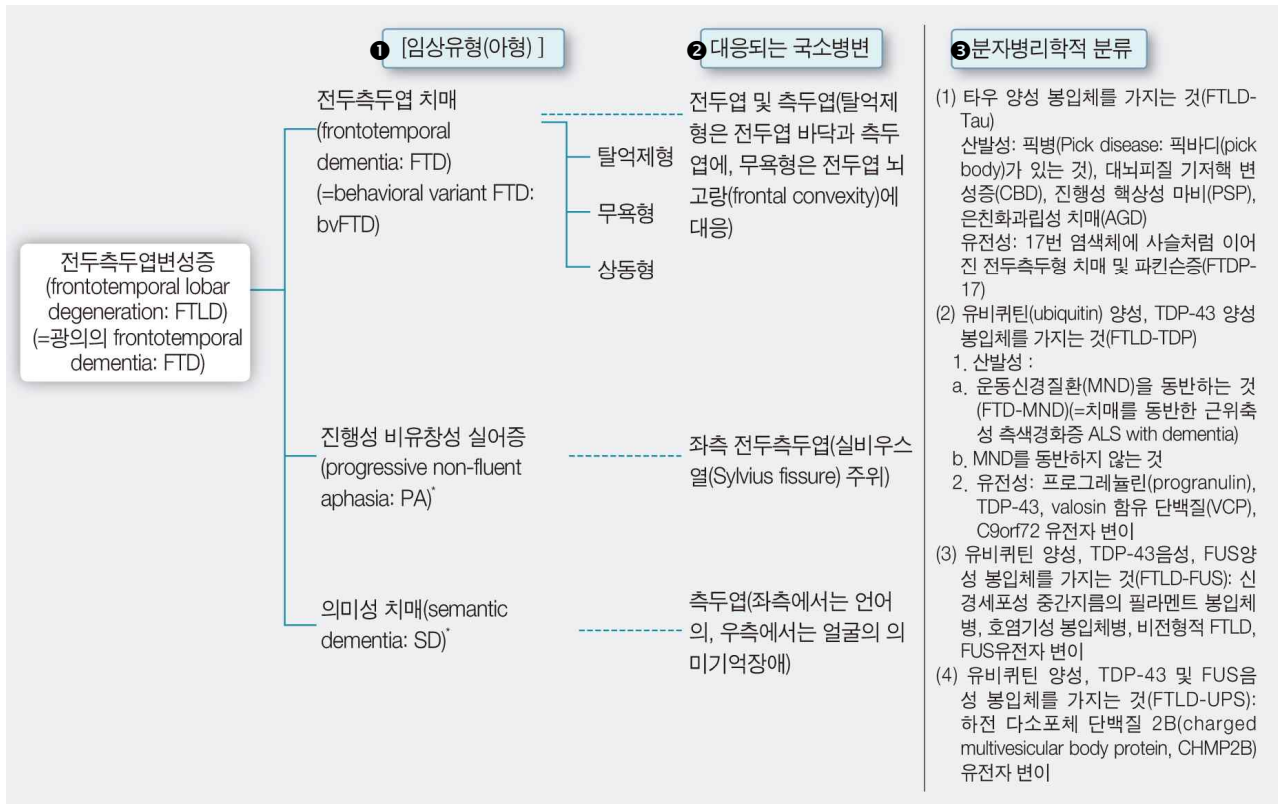
개요	• 서서히 발생하여 진행되는 언어장애 • 단어 유창성 유지 • 정확한 사물의 명칭이나 고르기 못함 → 언어 의미 체계의 손상으로 추측 (진행성 비유창성 실어증과의 차이점) • 뇌위축은 주로 비대칭적으로 발생 ┐ 좌측: 언어장애 └ 우측: 얼굴인식불능증
증상	☑ 베르니케 실어증과 유사함 • 이름 대기와 알아듣기 장애 • 의미착어증 • 얼굴인식불능증, 물체인식불능증 등 • 시각인지 능력, 따라 말하기, 규칙어 받아쓰기 등은 유지

3. 영상 검사

[Brain CT, MRI] 전두엽/측두엽의 위축		[SPECT, PET] 전두엽/측두엽에서 혈류, 대사의 저하	
[Pick형의 CT사진]	[Brain MRI T2 강조 영상]	[정상]	[전두측두엽 치매]
			
전두엽의 mild한 위축 有	전두엽, 측두엽 경도 위축		화살표 방향에서 나타남

4. 진단/감별 진단

- 탈억제적 행동 인격 변화나 진행성 경과, 전두/측두 위축의 임상소견 및 영상 소견
- 기억장애를 특징으로 하는 알츠하이머병 이외의 질환, 대뇌피질 기저핵 변성증, 운동신경원질환 등과 감별



5. 예후

- 대부분 10년 이내 사망 (완만한 진행성)

6. 치료

- 특이적인 치료법은 현재 없으며 대증요법 / 간호가 중심

[비교하기]

	뇌혈관성치매	알츠하이머병(Alzheimer's disease)	전두측두형 치매
연령	노년기 (50대부터)	노년후기 (70세 전후에 많다)	초로기 (65세 이하)
경과	계단형 악화	완서 진행성	완서 진행성
치매	반점 치매	전반성 치매	인격 변화, 행동 이상, 언어장애
국소증상	운동마비, 감각장애, 요실금 등	병소 증상은 적음	병소 증상은 적음
언어장애	구음장애	초기: 초피질성 감각실어 후기: Wernicke 실어	상동언어, 반향언어, 보속
인격	말기까지 유지	말기에 인격붕괴	초기부터 인격붕괴
병식	있음	없음 (초기에는 있음)	없음
CT/MRI	뇌경색병소	해마위축, 측뇌실하각확대	측두엽, 전두엽
SPECT 혈류 저하	전두엽 중심으로 다발성 부위	두정엽(parietal lobe) 후부대상회(cingulate gyrus)	전두엽, 측두엽
병리	다발성 뇌경색	노인반, 신경원섬유 변화	픽크체(Pick body), TDP-43 양성 봉입체

한방 파트 - 치매

[1] 병인병리

- 병인: 선천적인 부족, 후천적인 정신 자극 or 정지 실조, 노화로 인한 허쇠, 일산화탄소 중독, 납중독 등의 중독, 두부외상 및 다른 병에서의 전변 등
→ 본허/표실로 이해할 수 있음 (선천품부 부족과 후천조리 실양(失養)으로 인한 인체의 생리적 작용↓)

☑ 본허증 바탕 위에 火, 痰, 瘀가 상역하여 腦絡의 정신기능을 손상시키는 표실증의 협잡에 의해 발생함

분류		병리
허증(本虛)	髓海不足 (수해부족)	• 선천품부부족, 노화로 인한 허쇠, 또는 후천조리실양(失養)으로 인해 뇌에 영양공급이 부족하여 치매가 발생함 <소문, 오장생성론> 諸髓者 皆屬於腦 / <영추 해론> 腦者髓之海 → 髓海가 뇌와 밀접한 관계가 있음을 말함
	脾腎陽虛 (비신양허)	• 腎陽이 쇠하여 명문화가 쇠함 → 火不生土 → 脾가 건운하지 못하여 기혈이 부족해지고 기허하여 혈을 운행하는 힘이 없어져(氣虛運血無力) → 높이 위에 위치한 뇌에까지 上達하지 못하여 뇌혈관(腦脈)이 막혀(痺阻) → 元神이 손상되어 치매 발생
실증(表實)	瘀血內阻 (어혈내조)	☑ 외상에 의한 치매 • 출혈, 타박 외상에 의한 혈락(血絡)의 파손, 혈관의 경련/협착/파손, 열사(熱邪)가 영혈에 침입하고 열로 인해 진액이 손상되어 땀도 말라서 (熱盛傷陰, 汗出耗液) 血瘀가 발생하고 정체 → 운행불리(不利) → 뇌에서 清竅를 막아(閉阻)하여 치매 발생
	痰濁阻竅 (담탁조규)	• 폐, 비, 신, 삼초의 기능 실조 → 수액이 응취 → 담음 생성 → 순행에 장애를 초래함 → 뇌에서 清竅를 막아(閉阻)하여 치매 발생
	心肝火盛 (심간화성)	• 사려과다, 정신적 긴장이 심해짐 → 심화항염 → 간울화화 or 清竅를 막아(閉阻)하여 치매 발생

[2] 치료

☑ 허실 협잡이 기본 = 허증을 근본으로 갖고 있던 사람에게 실증이 추가되어 나타남

cf) 노인성 치매는 허증의 경향 / 혈관성 치매는 실증의 경향이 좀 더 강함

└ 補虛 - 허증일 때 (본허일 때)

└ 瀉實 - 실증일 때 (표실일 때)

- + 필요에 따라 두뇌를 활성화시키는 益智健腦 약재 (원지, 석창포, 백복신, 합환피, 호도육 등)를 가미하기도 함
- + 총명탕, 경옥고, 공진단을 빈용제제로 사용 가능

1. 변증시치

분류	증상	치법	치방
허증(本虛)	髓海不足 (수해부족) 기억력 감퇴(최근 감퇴가 더욱 심함), 힘이 없고 눕고 싶어함(無力欲臥), 두훈이명, 치아가 흔들림(齒枯髮焦), 요슬산연, 보행곤란, 혀가 마르고 담색(舌瘦色淡), 태박백, 맥침세약	보익간신 익수중지	대보원전, 호잠환 육미지황환, 기국지황환
	脾腎陽虛 (비신양허) 表情呆滯, 기억력 감퇴, 失論失算, 말로 뜻이 전달되지 않음(言不達意) 침을 질질 흘림(口涎外溢), 빈뇨 혹은 실금, 사지불온, 장명, 설사, 설질담백, 설체가 커짐, 설태백, 맥침세약, 兩尺尤甚	보익비신 생정익지	귀비탕, 팔미지황환
실증(表實)	瘀血內阻 (어혈내조) 表情遲鈍, 언어불리, 섬망, 쉽게 놀람(易驚恐), 사유이상, 기부갑작, 입이 마르지만 물을 마시고 싶지는 않음, 두 눈이 잘 보이지 않음(兩目暗昧), 설질암홍, 혹은 어반이 있음, 맥세삭	활혈화어 개규성뇌	통규활혈탕 도홍사물탕, 계지복령환
	痰濁阻竅 (담탁조규) 表情遲鈍, 기억력 감퇴, 혹은 웃고 우는 데 거짓 울음/웃음(哭笑無常), 음식 생각이 나지 않음, 완복창통비민불통감(不通感), 口多涎沫, 頭重如裹, 설질담, 태백니, 맥세할	건비화담 활담개규	온담탕, 척담탕 육군자탕, 반하백출천마탕
	心肝火盛 (심간화성) 기억력 감퇴, 판단이 흐림(判斷錯亂), 현훈두통, 성정조급, 초려불안, 심번불매, 여인다쟁, 구건구고, 소변단적, 대변비결, 설홍태황, 맥현삭	청열사화 안신정지	황련해독탕, 지보단 우황청심환, 조등산

* 수해부족: 영양 공급 부족으로 인한

* 어혈내조: 뇌혈관성 치매

2. 침구 치료

- 주치혈: 대추, 안면, 족삼리, 아문, 내관, 신문, 영도
- 가미혈: 태계, 삼음교(허중에 사용), 족삼리, 곡지(혈어에 사용), 풍릉, 삼음교(담탁에 사용), 내정, 행간(火盛에 사용)
- 예비혈: 신수, 벽아문
- 이침혈: 신문, 피질하, 신, 뇌점, 침(枕)

[3] 조리 및 예방

1. 조리

☑ 치료보다는 관리에 초점 !!! (치매는 비가역적이면서 진행성이기 때문에)

<전제 조건> 적절한 치료와 심리요법으로 증상을 완화시키고, 진행의 정지를 꾀할 수도 있지만, 관리 소홀로 일어나는 불의의 사고가 없도록 하는 것이 전제조건이 됨

- ① 원인 질환과 지병 등의 관리를 충실히 하며 술, 담배 등을 줄이기
- ② 일정한 생활공간 내에서의 규칙적인 생활이 좋음
(환경의 변화나, 새로운 공부거리, 새로운 생활 시간표, 운전, 여행 등은 오히려 불편해하거나 심리적 불안 유발 可)
- ③ 경증일 때부터 손으로 하는 놀이와 가벼운 게임, 운동 등으로 재미를 유발하면서 지능 훈련과 교육 시행
cf) 중증의 환자는 주의력이 부족하고 육체적으로도 반응이 느리므로, 사고의 위험이 높아 이러한 이유로 핵가족화된 사회에서의 개별적인 도움이 힘들기 때문에 전문 요양시설의 설립이 절실히 요구되고 있음

2. 예방

☑ 평소 심신의 건강을 유지하면서, 꾸준한 정신활동을 유지하며, 원인 질환의 이환을 막도록 하는 것

- ① 적당한 운동하기 (산보나 가벼운 체조, 태극권이나 기공 등)
→ 운동량이나 강도, 지속 순서는 체력에 맞게 해야 하고 항상 활동해야 함
- ② 기거에 있어 항상성이 있어야 하며 음식 조절하기
- ③ 일찍 자고 일찍 일어나며 정시에 식사 및 배변 습관 기르기, 일을 할 때도 합리적이며 본인에게 알맞은 일하기
- ④ 오락과 휴식도 적당히 취하기
- ⑤ 膳食 양생
→ 三定(定時, 定量, 定質) / 三高(고단백, 고불포화지방산, 고비타민) / 三低(저지방, 저열량, 저염), 兩戒(금연, 금부)

[4] 예후

- 알츠하이머 치매 - 점차 진행성으로 악화되어 비가역적인 경우 多
- 혈관성 치매 - 중풍의 치료를 통해 서서히 호전될 수 있음
➡ BUT, 혈관성 치매 경과 중 중풍이 재발하거나 알츠하이머 치매가 혼합된다면 이때는 점차 악화될 수도 O
(= 중풍의 관리 및 재발 방지와 함께 전신 기능(체력/정신력)의 강화에 노력해야 함)
- 속발성 치매 - 원인 질환의 치료에 비례하여 치매 증상이 호전되는 경우 多